

ÉVALUATION LOMBAIRE INITIALE

Première consultation rachis lombaire



#01/12
2L

ÉTAPE PARCOURS

TO — Première consultation

DURÉE CHIR

≈ 2 minutes

QUI REMPLIT

Patient · Tablette · 80%

Chirurgien · Ordi · 20%

Quels sont les examens d'imagerie disponible(s) pour faire le diagnostic ? QCM

RADIO

SCANNER

IRM

EOS

Voir la sous question

DIAGNOSTIC LOMBAIRE NEUROLOGIQUE PRINCIPALE QCM

Non NEURO

Avec déficit NEURO :

Voir les 3 sous questions

PROJET THERAPEUTIQUE LOMBAIRE QCM

Liste des réponses

Ajouter une sous question

NIVEAU DIAGNOSTIC LOMBAIRE PRINCIPALE QCM

L5S1

L4L5

L3L4

L2L3

L1L2

Ajouter une sous question

DIAGNOSTIC LOMBAIRE QUI EXPLIQUE LA SYMPTOMATOLOGIE PRINCIPALE QCM

Liste des réponses

Voir les 15 sous questions

Lésion associée sur l'imagerie QCM

Hernie discale lombaire

Sténose lombaire centrale

Sténose lombaire foraminale

Discopathie

SPL dégen

SPL par lyse

Scoliose

Voir la sous question

LÉGENDE COULEURS

● À toi de remplir

● Champ critique

● Patient ou auto

LE PATIENT A
DÉJÀ TOUT FAIT
SUR LA TABLETTE

- Motif, trajet, symptômes, côté, ancienneté
- Traitements déjà entrepris, antécédents, médicaments
- EVA dos / EVA jambe (0 à 10)

TOI, TU AS 6
DÉCISIONS À
PRENDRE

- 1. Imagerie disponible (Radio · Scanner · IRM · EOS)
- 2. Niveau diagnostic principal (L5S1 → L1L2)
- 3. Diagnostic neurologique (Non NEURO ou Avec déficit)
- 4. Diagnostic qui explique la symptomatologie
- + 2 autres

SELON TON
DIAGNOSTIC
PRINCIPAL, 1 À 3
SOUS-QUESTIONS
S'AFFICHENT

- HDL → Type ·
Côté · Récidive ·
Migrée ·
Classification MSU
- Sténose centrale
(CLE) → Grade
Schizas
- Sténose
foraminale ou
récessus → Côté
- SPL dégénératif →
GRADE SPL DEG (1
à 3)
- + 2 autres

6

6 DÉCISIONS. 2 MINUTES.

Le patient a fait le reste.

DÉCISIONS

POURQUOI CE 2L BIEN REMPLI CHANGE TOUT

- C'est le TO de chaque patient. Sans lui, aucune comparaison post-op n'est possible.
- Le PROJET THÉRAPEUTIQUE est la variable cible Y de toutes nos études (médical vs chirurgical).
- Les sous-questions (Pfirmann, Modic, Schizas, Méyerdíng, MSU) ne s'affichent que quand elles sont pertinentes — Follow t'évite de tout remplir.
- Études en cours qui en dépendent : ACCEPT (1 000 patients hernie), CLE 2023/2024.
- Sans le 2L de référence, le patient n'entre dans aucune étude SRC.

POSITION DANS LE PARCOURS SRC

1D	2L	4L	5L	2C	4C	5C	6a	6b	1M L	3M L	6M L	1A L	2A L	1M C
3M C	6M C	1A C	2A C	8L	8C	ODI	NDI							

